

慢性肾炎的中医辨证论治经验举隅

田永明

(天津中医药大学第一附属医院国家中医针灸临床医学研究中心 天津 300381)

[摘要] 目的:举例并总结慢性肾炎的中医辨证论治经验。**方法:**根据慢性肾炎的中医临床表现进行分型,区别其本标之症,并结合临床治疗案例,探讨慢性肾炎的中医辨证论治方法。**结论:**临床慢性肾炎治疗,需以中医辨证治疗为主,同时结合病症、实验室指标,开展扶正补虚、活血化瘀、清热利湿等治疗方法。

[关键词] 慢性肾炎;中医辨证论治

中图分类号:R692.3

文献标识码: B

文章编号:1006-0979(2024)05-0087-03

DOI:10.16040/j.cnki.cn15-1101.2024.05.029

慢性肾炎是一种肾小球免疫炎症性疾病,临床表现为长期持续性尿检异常,多有蛋白尿、水肿、高血压等肾功能损伤症状,其发病原因与肥胖、长期劳累等多因素有关^[1-2]。慢性肾炎发病早期多隐匿,不易被重视,且病情进展缓慢,易对肾功能造成不同程度的损害,发现时多为晚期,肾功能已恶化,甚至可能出现慢性肾衰竭、尿毒症等情况^[3-4]。因本病为人体免疫反应性疾病,因此在西医领域对该疾病的治疗,通常以降低尿蛋白指标、控制血压值稳定、实现人体免疫抑制等作为治疗原则,但在目前临床上尚无特效药实现根治^[5-6]。中医认为慢性肾炎多属中医“水肿、血尿、精微外泄”等范畴,其发病多因外感风邪、肺气不宜、通调水道功能失调而影响于肾,或因湿热内浸、水湿浸渍、劳倦过度、肾气受损而致发病^[7-8]。其中医辨证论治过程如下:

1 辨证分型

根据中医学理论,肾脏对应五行属水,即是肾脏在人体中起到排尿和调节体液平衡的功能。肾五行属水、乃先天之本^[9-10];脾五行属土,乃后天之本,具有承担化生气血的作用^[11]。而一旦出现肾虚,则阳气不足,将会导致脾虚失运,清阳不升,均可导致精微下泄,故出现蛋白尿、水肿等临床诸症^[12]。因其病因复杂,临床所见也表现各异,同一证型症状也可能表现多样,很难从某一症状角度分型,根据中医辨证方法,其大体可分型如下:

1.1 本证

1.1.1 肺肾气虚型 患者病位主要在肺肾,中医症状多为面浮肢肿、面色萎黄;少气乏力;易感冒;腰脊疼痛;舌淡、苔白润、有齿印、脉细弱。具备以上任意三项症状者,即可判断为肺肾气虚型。

1.1.2 脾肾阳虚型 患者病机主要在脾肾,中医症状表现为面浮肢肿、少气无力、腰脊酸痛等,中医查体存在舌淡、舌苔薄白、有齿痕、脉细弱。具备以上任意三项症状者,即可判断为脾肾阳虚型。

1.1.3 肝肾阴虚型 患者病机主要在肝肾,中医症状多为眼睛干涩、视力下降、腰脊疼痛加重、梦遗或月经失调、手足心热、舌红少苔、脉弦数或细数。具备以上任意三项症状者,即可判断为肝肾阴虚型。

1.1.4 气阴两虚型 患者病机主要与肝、肾、脾等均有关,中医

症状多为面色浮黄、神疲肢倦、口干咽燥、舌质偏红、少苔、脉细弱。具备以上任意三项症状者,即可判断为气阴两虚型。

1.2 标证 慢性肾炎患者由于个体差异和病因、病理等情况不同,病情轻重和病程长短不一,每一种本证往往有兼夹一种甚至数种标证,临床上需结合临床症状和实验室检测情况,灵活判断,掌握有机辨证^[13,14]。其标证大体可分列如下:

1.2.1 外感风邪 患者或感受风寒:症状表现为恶寒发热,无汗头痛,鼻塞声重,鼻涕清涕,喉痒咳嗽,舌苔薄白,脉浮偏紧。

患者或感受风热:症状表现为发热恶风,口渴咽痛,鼻涕浊涕,舌质淡红,舌苔薄黄,脉浮偏数。

1.2.2 水湿 以肢体沉重酸困,头重如裹为主要表现。如脾虚湿盛,可表现腹胀、大便溏泄、身重。临床患者常出现全身中度以下水肿或有胸腹水。

1.2.3 湿热 患者呈现较为明显的皮肤症状,如有疖肿,疮疡等,并伴有咽红疼痛。同时存在口干不欲饮,胸闷纳呆症状,小便排出量少,且短赤涩热或涩痛。

1.2.4 血瘀 患者表现为面色晦暗,手足麻木甚或肌肤甲错,腰部刺痛;舌质紫暗或有瘀点、瘀斑,脉细而涩,尿检测出尿纤维蛋白降解物含量升高,血液检测常发现其全血及血浆黏度升高。

1.2.5 湿浊 患者常出现恶心呕吐,食少纳呆,精神萎靡,身重困倦等症,肾功能易检测出尿素氮、血肌酐偏高。

2 辨证论治

祖国医学认为,水肿、血尿、精微外泄等病者,其本在肾,其治在脾。由于临床上多数慢性肾炎患者的患病时间较长,治疗病程长,大多患者体质虚弱,基于发病过程而言,患者总属正虚邪实,虚实夹杂互见^[15,16]。常见病症有风邪乘袭、水湿停滞、湿热内蕴、瘀血阻滞。

2.1 论治举隅 本着辨证论治与标本缓急的中医治疗特点^[17],现做如下论治举隅:

2.2.1 肺肾气虚型论治举隅 此型主要病发于慢性肾炎急性发作患者、肾病综合征并发感染患者等群体中,多受感染影响发展为急性肾小球肾炎,反复发作可致体质虚弱,免疫力功能降低。治疗方法:肺肾同治,滋阴养肺。

病案举例:陈某,女,42岁,患慢性肾炎已5年,患者素体虚

弱,面部、下身俱肿,下肢尤甚,按之如泥囊,小便短少,腰部酸楚,少气乏力,纳呆泛恶,舌质淡,舌苔白腻,脉象沉而弱,尿检:红细胞(++),蛋白(++).诊断为脾虚不运,水湿内泛,上干肺娇,下壅肾关所致,证属于肺肾气虚型。方药:选用防己黄芪汤加减治疗,药用黄芪、白术、防风、茯苓、泽泻、益母草。20剂,每日1剂,水煎服。服药后,水肿消去,其余诸症皆有缓解,尿潜血正常,尿蛋白+-,后定期检测尿蛋白长期稳定于--+-,病情控制良好。

2.2.2 脾肾阳虚型论治举隅 该证型以慢性肾炎肾病型患者多发,在中医理论中,其是由病久而出现邪气伤阳,且水液停滞。治疗方法:健脾补肾、温阳利水。

病案举例:王某,男,46岁,患慢性肾炎已8年,患者临床诊断出肾功能表现为轻度受损,下肢凹陷性水肿,面色无华,神疲倦怠,肢体寒冷,腰背疼痛,伴有明显腹水、腹胀、便秘症状,性功能降低,舌暗淡苔白,体胖脉细,尿检:红细胞(++),蛋白(+++).诊断为脾气虚陷,清气不升,精微下注所致,证属于脾肾阳虚型。方药:选用实脾饮加减治疗,药用黑附子、白术、茯苓、泽泻、生姜、党参、肉桂、丹参。10剂,每日1剂,水煎服。服药后,水肿、腹水症状消退,尿检蛋白(+).续用7剂,症状明显改善,复查尿常规尿潜血阴性,尿蛋白+-。

2.2.3 肝肾阴虚型论治举隅 此型多见于慢性肾炎高血压型及IgA肾病,因郁热耗损真阴或病久阳损及阴。治疗方法:滋部肝肾、潜阳活血。

病案举例:李某,女,42岁,患慢性肾炎已7年,患者常出现血尿、蛋白尿,头晕头痛,口燥咽干,眼干,视物模糊,腰痛酸软,舌微红,脉细数,尿检:红细胞(+++),蛋白(++).诊断为肾阴亏损,封藏失职,精微漏泄所致,证属于肝肾阴虚型。方药:以杞菊地黄汤加减治疗,药用枸杞子、菊花、生地黄、丹皮。服药2剂后,尿量增多,尿检蛋白减少。续用7剂,后日感疲劳。加制生地六味汤,滋补肝肾,清热滋阴,药用生地黄、首乌、女贞子、知母、黄柏、黑豆。服用7剂,效果甚好,后复查尿常规血尿(+)、尿蛋白消失。

2.2.4 气阴两虚型论治举隅 慢性肾炎后期以及缓解期或恢复期多发气阴两虚症状,该证型的发生原因则是患者体质耗损,导致气阴不足。治疗方法强调益气养阴、清热活血。

病案举例:方某,男,45岁,患慢性肾炎已5年,患者面色浮肿,神情倦怠,手足心热,夜寐不安,咽痛,咽部暗红,舌红,脉细,尿检:红细胞(+),蛋白(+++).诊断为肾元不固,阴精下渗,阴阳气虚,证属于气阴两虚型。方药:以参芪地黄汤加减治疗,药用党参、黄芪、杜仲、熟地黄、当归、枸杞子、山萸肉、泽兰。10剂,每日1剂,水煎服。服药后,精神好转,续用7剂,浮肿消失,后继饮7剂后复查尿常规尿蛋白(+),红细胞(-)。

3 论治总结

慢性肾炎长期蛋白流失,多并发水肿,患者脾肾虚损,同时瘀血、浊邪、痰湿、毒热等病理因素贯穿病变始终,临床可从扶正补虚、活血化瘀、清热利湿等方面开展治疗^[18,19]。

3.1 扶正补虚法 治疗慢性肾炎的关键在于扶正补虚,实为补益脾肾。因此,在中医治疗中,侧重以扶正气,调脾胃、充气血为主

要原则,有效缓解患者体虚状态,提高免疫能力和抗病能力。

3.2 活血化瘀法 慢性肾炎在发展过程中,瘀血内停、瘀浊阻滞与热邪互结,将会致使尿蛋白渗泄,从而患者表现出蛋白尿等临床症状。同时瘀血与热邪互结加重,又可促使患者肾功能下降。由此,在治疗期间,应当与预防慢性肾炎持续恶化发展、保障肾功能减退得到延缓等为目标。而通过应用活血化瘀类中药进行治疗,有助于患者的血管得到扩张,有效减小血管阻力,增加血流量运行循环,进而改善患者肾组织内的血氧供应情况^[20]。

3.3 清热利湿法 水湿与热邪互结是慢性肾炎患者的主要病因,同时也是引发反复感染和炎症产生的重要因素之一。通常情况下,水湿与热邪互结在疾病发生和发展中,占有较大的比重,往往贯穿病变始终。为此,在治疗中,需遵循清热利湿的原则,改善肾气不足、水湿内停等症状。

参考文献

- [1]徐飞鹏,沈沛成.营卫理论在慢性肾炎中的应用基础[J].辽宁中医杂志,2021,48(4):61—64.
- [2]王健,王耀光.基于数据挖掘的当代中医治疗慢性肾炎蛋白尿证治方药规律研究[J].上海中医药杂志,2019,53(4):17—21.
- [3]向英歌,张治华.益肾止血方治疗慢性肾炎血尿气阴两虚夹瘀型的效果观察[J].宁夏医科大学学报,2020,42(11):1173—1176.
- [4]马思佳,赵明明,常美莹,等.黄芪治疗慢性肾炎中的网络药理学研究[J].世界中西医结合杂志,2020,15(08):1467—1472,1479.
- [5]林辉,肖蓓,孙雁洁.雷公藤多苷治疗慢性肾炎患者的临床研究[J].中国临床药理学杂志,2020,36(18):2756—2758.
- [6]刘签兴.基于“肺肾相关”理论的慢性肾炎中医治疗[J].北京中医药,2020,39(8):854—856.
- [7]费佳,马源.朱辟疆治疗慢性肾小球肾炎经验[J].中国中医药信息杂志,2019,26(9):120—122.
- [8]黄小娟,孙伟.孙伟教授治疗肾炎性血尿临床经验[J].浙江中医药大学学报,2018,42(1):81—83,86.
- [9]张尧,陈素枝,高飞,等.檀金川教授治疗慢性肾小球肾炎的临床经验[J].天津中医药,2022,39(5):632—636.
- [10]袁慧婵,赵进喜,宫晴,等.慢性肾炎大量蛋白尿中医治疗四法[J].环球中医药,2019,12(1):129—131.
- [11]王健,王耀光.从肾风、瘀血、湿浊论治慢性肾炎蛋白尿[J].环球中医药,2020,13(1):86—88.
- [12]秦燕,庞浩龙,贡联兵.慢性肾小球肾炎中成药的合理应用[J].人民军医,2017,60(5):512—514.
- [13]王萍,赵宏波,张振忠.辨证治疗中老年慢性肾炎探讨[J].陕西中医,2016,37(11):1522—1523.
- [14]陈小燕.王维英主任医师治疗慢性肾小球肾炎的临床经验[J].陕西中医,2018,39(1):110—112.
- [15]黄佳慧,张蕾,侯海晶,等.名老中医杨霓芝治疗慢性肾小球肾炎经验[J].辽宁中医杂志,2022,49(6):55—57.

- [16]孙成力,陆文,何立群,等.慢性肾炎应从少阳枢机论治[J].中国中西医结合肾病杂志,2019,20(8):747—748.
- [17]叶可平,谭晓宁,于大君.从湿热论治慢性肾炎蛋白尿体会[J].江苏中医药,2020,52(8):44—46.
- [18]赵大鹏,张媛媛,王茹,等.李延教授治疗慢性肾小球肾炎经验浅析[J].天津中医药大学学报,2020,39(4):385—388.
- [19]李凯,李秘,谢毅强,等.国医大师郭子光从风论治慢性肾炎经验撷英[J].中华中医药杂志,2020,35(10):4999—5002.
- [20]严晓枫,王素芹,张芳芳.严冰治疗慢性肾炎用药之经验[J].江苏中医药,2021,53(7):21—23.

小柴胡汤合方治疗失眠症的体会

徐前威

(北京大学第三医院中医科 北京 100191)

[摘要] 失眠症是常见的临床疾病,严重困扰着人们的日常生活。失眠症的发生和少阳枢机不利密切相关。小柴胡汤首见于《伤寒杂病论》,被历代医家认为是和解少阳的经典名方。临床运用小柴胡汤合方治疗失眠,取得良效,今探讨之,以飨同道。

[关键词] 失眠症;少阳枢机不利;小柴胡汤;合方治疗

中图分类号:R256.23

文献标识码: B

文章编号:1006-0979(2024)05-0089-03

Experience of Xiao Chaihu Decoction in the Treatment of Insomnia

XU Qianwei

(Department of Traditional Chinese Medicine, Peking University Third Hospital, Beijing 100191)

[Abstract] Insomnia is a common clinical disease, which seriously puzzles people's daily life. The occurrence of insomnia is closely related to the disadvantage of Shaoyang axis. Xiaochaihu Decoction was first seen in the treatise on Shanghan Zabing Lun, which was considered by doctors of all dynasties as a classic prescription to reconcile Shaoyang. The clinical application of Xiaochaihu Decoction in the treatment of insomnia has achieved good results. Today, we will discuss it for our colleagues.

[Key words] Insomnia; Shaoyang axis is unfavorable; Xiao chaihu decoction; Combined prescription treatment

失眠症是指患者在适当的睡眠机会和睡眠环境下,出现入睡困难、睡眠维持困难、易醒、早醒、睡眠质量差和睡眠总时间不足等症状,同时伴有精力下降、情绪低落或容易激惹、身体不适等白天功能下降,不能满足日常生理需求,对患者白天生活、学习和工作造成严重影响的一类病症^[1-4]。随着现代生活节奏的加快和工作压力的增加,失眠的发病率越来越高,在成人中符合失眠症诊断标准者达10%~15%,且呈慢性化过程,近半数严重失眠可持续10年以上^[5]。在美国、欧洲、中国罹患人群比例分别约为33%、4%~22%、40%。其可导致焦虑、抑郁、恐惧、免疫力减退,甚至诱发精神神经异常、糖尿病、冠心病、消化道疾病等,严重影响患者的身心健康^[6-8]。

目前临床治疗失眠症中多使用西药,然而长期使用西药,会产生许多不良反应,甚至导致患者严重药物依赖^{[2]、[9]}。随着人们对中医学认识的加深,中医药以其较少不良反应,越来越受患者的欢迎。

失眠症在中医学中有“不寐”“不得眠”“不得卧”等称谓。中医学认为,失眠的发生与脑、心、肝均有关,脑为元神之府,为主宰人精神思维活动的中心,心主血脉,藏神,若心血不能充盈脉道,无法向脑部供应足够的养分,则元神和心神不能守舍,出现失眠。同样肝主疏泄,调畅情志,若肝气郁结,情志失常,亦

会导致失眠的发生^[10]。

中医学普遍认为失眠的核心病机是阳不入阴,而少阳枢机不利是影响阳不入阴的关键因素^[11-12]。因此可以认为少阳枢机不利为失眠的主要病机。小柴胡汤首见于东汉张仲景《伤寒杂病论》中,具有和解少阳,疏利肝胆的功效,小柴胡汤加减方能养心安神、调理气血,对失眠的治疗有一定效果^[13]。

《伤寒论》96条:“伤寒五六日中风,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕。”263条:“少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。”266条:“本太阳病不解,转入少阳者,胁下硬满,干呕不能食,往来寒热,尚未吐下,脉沉紧者,予小柴胡汤。”这是《伤寒论》论述小柴胡汤证的三条主要条文,体现了小柴胡汤证辨证的核心病机及辨治要点。小柴胡汤由柴胡、黄芩、半夏、人参、炙甘草、生姜、大枣等组成。《神农本草经》在论述方中诸药时言柴胡“主心腹,去肠胃中结气...推陈致新。”《药品化义》言柴胡“味微苦,主疏肝”,现代药理研究表明^[14],柴胡可以通过调节神经内分泌系统、改善炎症信号通路等方面发挥抗抑郁作用。黄芩“主诸热黄疸...”,半夏“主伤寒...下气...头眩胸张...”,人参“主补五脏,安精神,定魂魄,止惊悸,除邪气,明目,开心益智”,甘草“主五脏六腑寒热邪气,坚筋骨,长肌肉...”,生姜“主胸闷咳逆上气,安中...生者尤良”,大枣“主心腹邪气,安中养脾...补少气,少津液...大惊...”。综上方中各药的论述,柴胡味苦寒,能疏肝,透少阳之邪于外,黄芩苦寒,清利肝胆之郁热。“见